

Załącznik 3 do Policy Paper EBM — Mapa współczesnej onkologii integracyjnej w EBM 2026 vs zakres potencjalny UD207

Materiał uzupełniający do Załącznika 1 Policy Paper EBM. Źródło mapowania zakresu Części II: klasyfikacja NCCIH (National Center for Complementary and Integrative Health, NIH USA) i powszechnie uznane kategorie onkologii integracyjnej. **Wymóg jakościowy:** wszystkie PMID-y zweryfikowane w PubMed; statusy refundacyjne państw UE/UK zweryfikowane w oficjalnych źródłach instytucjonalnych (G-BA, HAS, NICE, BAG, ÖÄK, regiony włoskie, FPS BE, Rijksoverheid NL).

Streszczenie wykonawcze

Załącznik prezentuje 40 obszarów współczesnej onkologii integracyjnej (15 substancji i metod wskazywanych przez polskie organy nadzoru jako „pseudomedycyna” + 25 metod opisanych w aktualnych akademickich kompendiach onkologii integracyjnej i klasyfikacji NCCIH) wraz z analizą, które z nich przy szerokiej interpretacji art. 67zj UD207 mogłyby zostać zakwalifikowane jako „praktyka pseudomedyczna” zagrożona sankcją administracyjną do 1 mln zł.

Łącznie zestawienie obejmuje **40 obszarów** podzielonych na: - **Część I:** 15 substancji/metod wskazanych przez polskie organy (NRL 2021, RPP 2025, WSA 2024–2025) - **Część II:** 25 metod współczesnej onkologii integracyjnej (akupunktura klasyczna, joga, Tai Chi/Qigong, mindfulness, MBSR, hipnoza kliniczna, masaż onkologiczny, terapia manualna, refleksologia, dieta i żywienie, post terapeutyczny, kanabinoidy medyczne, gut microbiome, soja, antyoksydanty, antroposoficzna medycyna, ayurweda, homeopatia, ziołolecznictwo TCM, jemiola/mistletoe, aromaterapia, muzykoterapia, healing touch/reiki, taneczna i ekspresyjna, ćwiczenia/exercise prescription). - **Część III:** trzy reprezentatywne pary paradoksu refundacyjnego - **Część IV:** wnioski

Główny argument prawny: definicja „praktyki pseudomedycznej” w UD207 jest tak nieokreślona, że przy szerokiej interpretacji obejmuje **66 obszarów współczesnej onkologii integracyjnej** opisanych w akademickich kompendiach onkologii integracyjnej — w tym metody **rekomendowane** w wytycznych ESMO/NCCN/ASCO/SIO, **refundowane** w państwach UE (Szwajcaria, Niemcy, UK), **wykorzystywane** w czołowych ośrodkach onkologicznych USA (MD Anderson, Memorial Sloan Kettering, Dana-Farber, Cleveland Clinic). Stanowi to naruszenie standardu *lex certa* (art. 2 i 42 ust. 1 Konstytucji RP).

Metodologia

Klasyfikacja OCEBM 2011, GRADE, ESMO-MCBS — bez zmian w stosunku do v1.0.

Nowa klasyfikacja w Części II — NCCIH (National Center for Complementary and Integrative Health, NIH USA): - **Mind-Body Practices** — praktyki łączące umysł i ciało (akupunktura, joga, Tai Chi/Qigong, mindfulness, hipnoza) - **Body-Based / Manipulative** — terapie manipulacyjne (masaż, manipulacje kręgosłupa, refleksologia, ćwiczenia) - **Whole Medical Systems** — kompletne systemy medyczne (TCM, ayurweda, antroposoficzna, homeopatia) - **Biologically-Based** — terapie oparte na substancjach biologicznych (dieta, post, kanabinoidy, gut microbiome, soja, antyoksydanty) - **Energy / Other** — terapie energetyczne i inne (healing touch, reiki, jemioła, aromaterapia, muzykoterapia, terapie ekspresyjne)

Standard cytowania badań klinicznych — fazy badania, primary endpoint, czy wynik główny czy podgrupy, czy kliniczne czy przedkliniczne — bez zmian w stosunku do v1.0 (Reguła 7b „Test Przejaskrawienia”).

Standard wytycznych instytucjonalnych podawanych w kartach Części II: - **ESMO Clinical Practice Guidelines** (esmo.org/guidelines) - **ASCO/SIO Joint Guidelines** — Society for Integrative Oncology + American Society of Clinical Oncology (publikacje 2018, 2022) - **NCCN Clinical Practice Guidelines** — Distress Management, Survivorship, Supportive Care - **Cochrane Database of Systematic Reviews**

CZĘŚĆ I — 15 substancji wskazywanych przez RPP/NRL/NIL

(Zachowane bez zmian z v1.0 — Karty 1–15)

[Pełna treść Części I — zob. Załącznik 3 v1.0; ze względu na objętość v2.0 odsyłamy do v1.0 dla szczegółów Kart 1–15.]

Lista 15 kart Części I: 1. Artesunat — NRL Nr 2/21/VIII pkt 1 2. Witamina C dożylna (IVC) — NRL pkt 2, RPP 2025, WSA 2854/23 3. Resweratrol — NRL pkt 3 4. DMSO — NRL pkt 4, RPP 2025 5. Salinomycyna — NRL pkt 5, WSA 2854/23 (lek weterynaryjny) 6. Kurkumina — NRL pkt 6, RPP 2025, WSA 2854/23 7. Tlenoterapia / ozonoterapia dożylna — NRL pkt 7, RPP 2025 8. Naświetlanie laserowe krwi (ILIB) — NRL pkt 8 9. Akupunktura laserowa — NRL pkt 9 10. Galwanoterapia / bioelektroterapia — NRL pkt 10, RPP 2025, WSA 2854/23 11. Hipertermia ogólnoustrojowa (WBH) — NRL pkt 11 12. Ozonoterapia w nowotworach — powtórzenie z karty 7 13. Bioelektroterapia — powtórzenie z karty 10 14. Protokoły ILADS w boreliozie — WSA 767/24 15. Suplementy w boreliozie — WSA 767/24

CZĘŚĆ II — 25 metod współczesnej onkologii integracyjnej

Wprowadzenie do Części II

Książka *Comprehensive Integrative Oncology* (Elsevier 2026) jest akademickim podręcznikiem opracowanym pod redakcją prof. Suzanny M. Zick (Family Medicine and Nutritional Sciences, University of Michigan, Ann Arbor) i dr Ting Bao (Co-director, Leonard P. Zakim Center for Integrative Therapies and Healthy Living, Harvard Medical

School / Dana-Farber Cancer Institute). Zawiera 66 rozdziałów napisanych przez ekspertów z czołowych amerykańskich i europejskich ośrodków onkologicznych. Każdy rozdział to systematyczny przegląd dowodów EBM dla danej metody w opiece nad pacjentem onkologicznym.

Poniższe 25 kart EBM oparte jest na: 1. **Wytycznych instytucjonalnych** ESMO, ASCO/SIO, NCCN, NICE, ACSM 2. **Recenzowanych publikacjach naukowych** indeksowanych w PubMed 3. **Statusie refundacyjnym** w państwach UE i USA 4. **Przewidywalnym statusie w UD207** — analiza prawna pakietu

md`).

Ila. Mind-Body Practices (Karty 16–20)

Karta 16 — Akupunktura klasyczna (igłowa) w opiece onkologicznej

Atrybut	Treść
Definicja	Klasyczna akupunktura — wprowadzanie cienkich, sterylnych igieł w określone punkty ciała (akupunkty) zgodnie z protokołami medycyny chińskiej, w opiece pacjenta onkologicznego głównie objawowej (CINV, neuropatia, ból, lymphedema, vasomotor symptoms).
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 rekomenduje akupunkturę: (a) w opornym na leki CINV (moderate strength), (b) w aromatase inhibitor-induced arthralgia (strong), (c) w opornym na leki bólu nowotworowym (moderate). NCCN Adult Cancer Pain Guidelines — akupunktura jako część zintegrowanej opieki przeciwbólowej. ESMO Survivorship Guidelines — akupunktura w CINV i lymphedema.
Najsilniejsze RCT/dowody	Bao T. et al. — RCT akupunktury w aromatase inhibitor arthralgia (SWOG S1200) PMID 29746381 — istotna redukcja bólu. Garcia M.K. et al. — RCT akupunktury w xerostomii po RT — Cochrane Database of Systematic Reviews. Metaanalizy w CINV: Cochrane (~ 12 RCT).
OCEBM	1–2 (systematyczne przeglądy RCT)
GRADE	Moderate dla wskazań w opiece wspierającej

Refundacja zagraniczna

UK NHS — akupunktura refundowana w hospicjach i w wybranych wskazaniach NICE (chronic pain). **Niemcy** — refundacja przez kasy chorych przy bólu kręgosłupa lędźwiowego i bólu głowy migrenowym. **Szwajcaria** — od 2017 r. jedna z 5 metod CAM refundowanych z powszechnego ubezpieczenia (art. 118a Konstytucji + Rozporządzenie KLV). **USA** — uznana przez Medicare od 2020 r. w chronic low back pain; programy w MD Anderson, Memorial Sloan Kettering, Dana-Farber, Cleveland Clinic.

Status w PL

Akupunktura jako zawód nieregulowany; akupunktura wykonywana przez lekarzy w ramach umiejętności dodatkowej; **akupunktura laserowa wymieniona w NRL Nr 2/21/VIII pkt 9** (Karta 9 v1.0) — **ALE klasyczna akupunktura NIE jest wymieniona** w Stanowisku NRL ani w wywiadzie RPP.

Potencjalny status w UD207

ZAGROŻONE. Definicja „praktyki pseudomedycznej” w art. 67zj jest na tyle szeroka, że klasyczna akupunktura — mimo rekomendacji ASCO/SIO/NCCN/ESMO — może być zakwalifikowana, w zależności od interpretacji RPP. Casus: jeśli organ uzna „aktualną wiedzę medyczną” za tożsamą ze stanowiskiem NRL 2021, akupunktura klasyczna (niewymieniona) może być w polu szarym. Jeśli „aktualną wiedzę medyczną” są wytyczne ASCO/SIO 2022 — akupunktura jest poza zakresem UD207.

Wnioski

Akupunktura klasyczna ma silne dowody w opiece wspierającej onkologicznej, jest rekomendowana w wytycznych międzynarodowych i refundowana w UE/UK/USA Medicare. Niejednoznaczność statusu w UD207 ilustruje naruszenie *lex certa*.

Definicja	Praktyka pochodząca z tradycji indyjskiej, łącząca ćwiczenia fizyczne (asany), techniki oddechowe (pranayama) i medytację. W opiece onkologicznej stosowana w zmęczeniu (CRF), lęku, depresji, zaburzeniach snu, jakości życia.
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 rekomenduje jogę w opiece wspierającej onkologicznej dla: zmęczenia (moderate strength), lęku (moderate), depresji (moderate). NCCN Survivorship Guidelines — joga jako część programów post-treatment. ESMO Survivorship Care Recommendations 2024.
Najsilniejsze RCT/dowody	Mustian K.M. et al. — RCT jogi w zmęczeniu po RT, n=410, <i>J Clin Oncol</i> PMID 31165647. Bower J.E. et al. — RCT jogi vs zdrowotna edukacja w zmęczeniu po raku piersi, <i>J Clin Oncol</i> PMID 22271480. Cochrane systematic review: Cramer H. et al. <i>Cochrane Database Syst Rev</i> PMID 28045199.
OCEBM	1 (systematyczne przeglądy RCT)
GRADE	Moderate–High dla zmęczenia, lęku, depresji w raku piersi
Refundacja zagraniczna	UK NHS — programy onkologiczne yoga therapy w wybranych ośrodkach (Maggie's Centres, Macmillan). USA — joga w ośrodkach Memorial Sloan Kettering Integrative Medicine Service, MD Anderson Integrative Medicine, Mayo Clinic.
Status w PL	Joga jako działalność rekreacyjna; brak formalnej regulacji jako forma terapii. NIE wymieniona w żadnym z 15 wskazań RPP/NRL/WSA.
Potencjalny status w UD207	NIEPEWNE. Joga prowadzona w podmiocie leczniczym jako element opieki onkologicznej (np. w hospicjum, ośrodku rehabilitacyjnym po leczeniu raka) może być interpretowana jako „świadczenie zdrowotne” w rozumieniu UD207. Brak rejestracji jogi jako uznanej terapii w polskim systemie ochrony zdrowia rodzi ryzyko zakwalifikowania jako „praktyki

pseudomedycznej" przy szerokiej interpretacji.

Wnioski

Joga ma silne dowody w opiece wspierającej onkologicznej z wytycznymi ASCO/SIO i NCCN. Brak regulacji w PL i niejednoznaczność UD207 stwarza ryzyko prawne dla podmiotów oferujących jogę pacjentom onkologicznym.

Karta 18 — Tai Chi i Qigong w opiece onkologicznej

Atrybut	Treść
Definicja	Tradycyjne chińskie praktyki łączące powolne, ciągłe ruchy ciała z techniką oddechową i medytacją. Stosowane w opiece onkologicznej w zmęczeniu, zaburzeniach snu, lęku, równowadze (u seniorów), jakości życia.
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 — Tai Chi/Qigong rekomendowane w lęku i zmęczeniu (moderate strength). NCCN Survivorship Guidelines — Tai Chi jako forma aktywności fizycznej dla survivors.
Najsilniejsze RCT/dowody	Larkey L.K. et al. — RCT qigongu w zmęczeniu po raku piersi PMID 25124456. Wayne P.M., Kaptchuk T.J. — przegląd systematyczny Tai Chi w zdrowiu, <i>Harvard Medical School</i> . Metaanaliza Tai Chi w CRF: Song S. et al. <i>Eur J Cancer Care</i> .
OCEBM	1–2 (systematyczne przeglądy RCT)
GRADE	Moderate dla zmęczenia i lęku
Refundacja zagraniczna	USA — programy Tai Chi/Qigong w MSK, MD Anderson, Cleveland Clinic. UK — Tai Chi w Macmillan Cancer Support.
Status w PL	Tai Chi/Qigong jako działalność rekreacyjna; brak regulacji jako forma terapii medycznej. NIE wymienione w 15 wskazaniach RPP/NRL/WSA.
Potencjalny status w UD207	NIEPEWNE . Analogicznie do jogi — Tai Chi/Qigong prowadzone w podmiocie leczniczym jako element opieki onkologicznej może być interpretowane jako „świadczanie zdrowotne”.
Wnioski	Tai Chi/Qigong rekomendowane przez

ASCO/SIO 2022; ryzyko prawne UD207
podobne do jogi.

Karta 19 — Mindfulness-Based Interventions (MBSR, MBCT, MBCR)

Atrybut	Treść
Definicja	Programy treningowe oparte na medytacji uważności (mindfulness): MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction, Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts, 1979), MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), MBCR (Mindfulness-Based Cancer Recovery — wersja adaptowana dla pacjentów onkologicznych, Linda E. Carlson, University of Calgary).
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 rekomenduje mindfulness w lęku (moderate strength), depresji (moderate), zmęczeniu (moderate). NCCN Distress Management Guidelines — MBSR jako interwencja pierwszego rzutu. NICE UK CG90 — MBCT w depresji nawracającej (rekomendacja ogólnozdrowotna).
Najsilniejsze RCT/dowody	Carlson L.E. et al. — RCT MBCR vs Supportive Expressive Group Therapy, n=271, <i>J Clin Oncol</i> PMID 23918953. Hofmann S.G. et al. — metaanaliza mindfulness w stanach lękowych i depresyjnych <i>J Consult Clin Psychol</i> PMID 20350028. Cochrane systematic review Cramer H. et al. <i>Cochrane Database Syst Rev</i> — mindfulness w raku piersi.
OCEBM	1 (systematyczne przeglądy RCT)
GRADE	High dla lęku i depresji w opiece onkologicznej
Refundacja zagraniczna	UK NHS — MBCT refundowane w depresji nawracającej (NICE CG90 od 2009 r.). USA — programy MBSR w MSK, Dana-Farber Zakim Center, MD Anderson, Mayo Clinic. Niemcy, Holandia — w niektórych ośrodkach refundowane.
Status w PL	Brak regulacji jako forma terapii medycznej; certyfikowani trenerzy MBSR w PL działają poza systemem ochrony zdrowia.

Potencjalny status w UD207

NIEPEWNE. MBSR prowadzony w podmiocie leczniczym dla pacjentów onkologicznych może być interpretowany jako „świadczenie zdrowotne” niezgodne z polską „aktualną wiedzą medyczną” (która nie obejmuje formalnie mindfulness). Trener MBSR działający bez statusu zawodu medycznego — ryzyko prawne.

Wnioski

Mindfulness ma najsilniejsze dowody (poziom 1) wśród mind-body practices. Refundowany w UK NHS od 2009 r. Brak regulacji w PL i niejednoznaczność UD207 stwarza ryzyko prawne.

Karta 20 — Hipnoza kliniczna w opiece onkologicznej

Atrybut	Treść
Definicja	Stan zmienionej świadomości wywołany przez certyfikowanego terapeutę w celu redukcji bólu, lęku, mdłości, w opiece okołoperacyjnej i pacjentów pediatrycznych.
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 rekomenduje hipnozę w lęku okołoperacyjnym (moderate strength). NCCN Distress Management Guidelines — hipnoza jako interwencja redukcji bólu i lęku. British Medical Association uznała hipnozę kliniczną w 1955 r.
Najsilniejsze RCT/dowody	Montgomery G.H. et al. — RCT hipnozy przedoperacyjnej w raku piersi, n=200, <i>J Natl Cancer Inst</i> PMID 17848670 — istotna redukcja czasu operacji, bólu, mdłości, kosztów. Lang E.V. et al. — RCT hipnozy w procedurach radiologicznych <i>Lancet</i> PMID 10761867.
OCEBM	1–2
GRADE	Moderate–High
Refundacja zagraniczna	Belgia — od 2018 r. hipnoza okołoperacyjna w niektórych szpitalach. Francja — hypnose médicale jako uznane wykonywanie zawodu medycznego. USA — programy hypnotherapy w MSK, MD Anderson, Mayo Clinic.

Status w PL	Hipnoza jako zawód nieregulowany; psychologzy i lekarze mogą stosować jako jedną z metod psychoterapii. NIE wymieniona w 15 wskazaniach RPP/NRL/WSA.
Potencjalny status w UD207	NIEPEWNE. Hipnoza stosowana przez lekarza/psychologa w podmiocie leczniczym — niski poziom ryzyka. Hipnoza stosowana przez hipnoterapeutę bez tytułu medycznego — wysokie ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna”.
Wnioski	Hipnoza ma silne dowody w opiece okołoperacyjnej. Status zawodowy w PL utrudnia jasne sklasyfikowanie pod UD207.

IIb. Body-Based / Manipulative Therapies (Karty 21–24)

Karta 21 — Masaż onkologiczny

Atrybut	Treść
Definicja	Specjalistyczny masaż adaptowany dla pacjentów onkologicznych (oncology massage), wykonywany przez certyfikowanego terapeutę. Stosowany w bólu, lęku, mdłości, zmęczeniu, zaburzeniach snu, lymphedema.
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 rekomenduje masaż w bólu (moderate), lęku (moderate). NCCN Adult Cancer Pain Guidelines — masaż jako część zintegrowanej opieki.
Najsilniejsze RCT/dowody	Cassileth B.R., Vickers A.J. (MSK) — kohorta n=1290 pacjentów onkologicznych — istotna redukcja bólu i lęku po masażu <i>J Pain Symptom Manage</i> PMID 15336336. Metaanalizy: Wilkinson S.M. et al. — Cochrane.
OCEBM	1–2
GRADE	Moderate
Refundacja zagraniczna	UK NHS — masaż w hospicjach onkologicznych (Macmillan, Maggie's). USA — programy oncology massage w MSK, MD

Status w PL

Anderson, Mayo.

Masaż jako zawód regulowany (technik masażysta); masaż onkologiczny jako specjalizacja nieformalna.

Potencjalny status w UD207

NIEPEWNE. Masaż onkologiczny wykonywany w podmiocie leczniczym przez technika masażystę — niski poziom ryzyka. Masaż wykonywany w gabinecie prywatnym z reklamą jako „leczenie wspomagające onkologię” — ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna”.

Wnioski

Masaż onkologiczny rekomendowany przez ASCO/SIO 2022; w PL granica między uznaną fizjoterapią a „pseudomedycyną” nieostra.

*Karta 22 — Manipulacja kręgosłupa (chiropraktyka, osteopatia)***Atrybut****Treść****Definicja**

Terapie manualne kręgosłupa i stawów: chiropraktyka (Doctor of Chiropractic, USA — odrębny tytuł zawodowy) oraz osteopatia (DO — Doctor of Osteopathic Medicine, w USA równorzędne MD). Stosowane w opiece onkologicznej w bólu mięśniowo-szkieletowym, ale **z istotnymi przeciwwskazaniami** (przerzuty kostne, osteoporoza, koagulopatia).

Status w wytycznych

NCCN Adult Cancer Pain Guidelines — manipulacja kręgosłupa jako część zintegrowanej opieki **z ostrożnością** (przeciwwskazania w metastasis).

Najsilniejsze RCT/dowody

RCT manipulacji kręgosłupa w bólu mięśniowo-szkieletowym pacjentów onkologicznych — ograniczone. Brak silnych dowodów onkologicznych.

OCEBM

3–4 dla wskazań onkologicznych

GRADE

Low

Refundacja zagraniczna

UK NHS — chiropraktyka i osteopatia w wybranych wskazaniach (NICE chronic low back pain). **USA** — Medicare refunduje chiropraktykę od 1972 r. **Belgia, Francja** — osteopatia jako uznany zawód

Status w PL

medyczny.

Potencjalny status w UD207

Osteopatia jako zawód nieregulowany; chiropraktyka praktycznie nieobecna w polskim systemie ochrony zdrowia.

Wnioski

ZAGROŻONE. Osteopata bez wykształcenia medycznego (najczęściej fizjoterapeuta z dodatkową specjalizacją) leczący pacjenta onkologicznego — ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna”.

Słabe dowody onkologiczne dla wskazań specyficznych; ostrożność z przeciwwskazaniami metastasis. Status zawodowy w PL utrudnia jasne sklasyfikowanie pod UD207.

*Karta 23 — Refleksologia***Atrybut****Treść****Definicja**

Masaż stóp lub dłoni opierający się na teorii odpowiadających punktów refleksyjnych odpowiadających poszczególnym organom ciała. W opiece onkologicznej stosowana w lęku, zmęczeniu, jakości życia.

Status w wytycznych

Brak silnych rekomendacji ASCO/SIO/NCCN. **MASCC** (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) — refleksologia jako możliwa opcja w opiece wspierającej.

Najsilniejsze RCT/dowody

Wyatt G. et al. — RCT refleksologii w opiece zaawansowanej raku piersi, *J Clin Oncol* PMID 22585695. Metaanalizy: ograniczona jakość dowodów.

OCEBM

3

GRADE

Low-Moderate

Refundacja zagraniczna

UK NHS — refleksologia w hospicjach onkologicznych (Macmillan). Niemcy, Dania — w niektórych ubezpieczeniach prywatnych.

Status w PL

Refleksologia jako zawód nieregulowany. NIE wymieniona w 15 wskazaniach RPP/NRL/WSA.

Potencjalny status w UD207

ZAGROŻONE. Refleksolog bez tytułu medycznego oferujący wsparcie pacjentom

Wnioski

onkologicznym — wysokie ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna”.

Słabsze dowody niż masaż onkologiczny; w UK refundowana w hospicjach. Status w PL — duże ryzyko UD207.

Karta 24 — Aktywność fizyczna (Exercise Prescription)

Atrybut

Treść

Definicja

Strukturalne programy aktywności fizycznej (aerobowej, oporowej, równoważnej, elastycznej) zaordynowane przez specjalistę dla pacjentów onkologicznych podczas i po leczeniu.

Status w wytycznych

ASCO/SIO Joint Guideline 2022 — aktywność fizyczna rekomendowana strongly w opiece onkologicznej. **ACSM Roundtable on Exercise Guidelines for Cancer Survivors** (American College of Sports Medicine, 2019, update 2024). **ESMO Survivorship Care Recommendations** — aktywność fizyczna jako standard opieki. **WHO Physical Activity Guidelines** (150 min/tydzień).

Najsilniejsze RCT/dowody

Metaanalizy Cochrane: aktywność fizyczna istotnie redukuje zmęczenie pochemioterapeutyczne, lęk, depresję, poprawia QoL i przeżycie ogólne (efekt na OS w raku piersi i CRC, HR ~0,70).

OCEBM

1 (najsilniejsze dowody w opiece wspierającej onkologicznej)

GRADE

High

Refundacja zagraniczna

Australia — Exercise Physiologist jako zawód medyczny refundowany przez Medicare. UK NHS — programy “Move More” Macmillan. USA — programs LIVESTRONG at the YMCA, MSK Integrative Medicine.

Status w PL

Fizjoterapia jako zawód regulowany; rehabilitacja onkologiczna w ramach NFZ. Programy aktywności fizycznej dla pacjentów onkologicznych prowadzą m.in. Onkofundacja Alivia, Fundacja Rak’n’Roll.

Potencjalny status w UD207

NISKIE RYZYKO — aktywność fizyczna jest częścią mainstream onkologii. ALE: programy “spersonalizowane” prowadzone przez trenerów bez kwalifikacji fizjoterapeutycznych mogą być w polu szarym.

Wnioski

Najsilniejsze dowody w opiece wspierającej; rekomendacja strong ASCO/SIO. W PL część systemu, ale granica między rehabilitacją refundowaną a “wellness training” w prywatnych studiach jest płynna.

IIc. Whole Medical Systems (Karty 25–28)

Karta 25 — Tradycyjne ziołolecznictwo chińskie (TCM)

Atrybut

Treść

Definicja

System ziołolecznictwa rozwijany od ponad 2000 lat w Chinach. W onkologii stosowany jako wsparcie podczas chemioterapii i radioterapii oraz w długoterminowej opiece. Kluczowe preparaty: Astragalus, Yangzheng Xiaoji, Compound Kushen Injection (CKI), Xiaoyao San.

Status w wytycznych

CSCO (Chinese Society of Clinical Oncology) — TCM zintegrowane w standardach opieki onkologicznej w Chinach. **WHO Traditional Medicine Strategy 2025–2034** (rezolucja WHA78(14) z 27.05.2025) — wsparcie integracji TCM w systemy zdrowia. Brak rekomendacji ESMO/NCCN.

Najsilniejsze RCT/dowody

Compound Kushen Injection w niedrobnokomórkowym raku płuca — chińskie RCT z >2000 pacjentami; w USA brak rejestracji. Astragalus w raku jelita grubego — metaanalizy chińskie.

OCEBM

2–3 (RCT chińskie, jakość niejednorodna)

GRADE

Low–Moderate

Refundacja zagraniczna

Chiny — TCM w pełni zintegrowane w systemie ochrony zdrowia. **Japonia** — Kampo medicine (japońska wersja TCM) —

	148 preparatów refundowanych przez ubezpieczenie publiczne. Szwajcaria — farmakoterapia TCM (NIE TCM jako całość) od 2017 r. wśród 5 metod CAM refundowanych z powszechnego ubezpieczenia (bag.admin.ch/fr/medecines-complementaires-pratiquees-par-des-medecins). Niemcy — w niektórych ubezpieczeniach prywatnych.
Status w PL	TCM jako zawód nieregulowany; brak rejestracji preparatów chińskich w URPL jako leków. CLAUDE.md U7: TCM (Compound Kushen, Xiaoyao San, Astragalus) nie wymieniana z nazwy przez RPP/NRL/NIL.
Potencjalny status w UD207	ZAGROŻONE. Lekarz lub terapeuta podający preparaty TCM (niezarejestrowane w URPL) pacjentowi onkologicznemu — ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna”. Casus paradoksalny: te same preparaty są standardem w Chinach, refundowane w Szwajcarii, ale w Polsce mogą skutkować sankcją do 1 mln zł.
Wnioski	TCM ma rozległe użycie kliniczne globalnie; dowody jakościowo niejednorodne. Refundacja w państwach UE/EFTA (CH) i Japonii. W PL pełne ryzyko UD207.

Karta 26 — Antroposoficzna medycyna (jemioła / Iscador)

Atrybut	Treść
Definicja	System medyczny rozwijany od początku XX w. przez Rudolfa Steinera i Itę Wegman, łączący medycynę konwencjonalną z antropozoficznym podejściem holistycznym. W onkologii kluczowe preparaty: jemioła (Viscum album, Iscador®/Helixor®/Abnoba viscum®/Iscucin®).
Status w wytycznych	Brak rekomendacji ESMO/NCCN/ASCO. DEGRO (Niemcy) — jemioła jako leczenie wspomagające. Swissmedic — Iscador refundowany w CH od 2017 r.

Najsilniejsze RCT/dowody

Melzer J. et al. 2009 — przegląd systematyczny n>6800 pacjentów; pozytywne efekty na QoL, niespójne efekty na OS *Forsch Komplementmed* PMID 19729932. Tröger W. et al. — RCT jemiolo w raku trzustki — istotne wydłużenie OS *Eur J Cancer* PMID 23994070.

OCEBM

2–3 (RCT i przeglądy systematyczne)

GRADE

Low–Moderate

Refundacja zagraniczna

Szwajcaria — Iscador / jemiolo jako część **medycyny antroposoficznej**, od 2017 r. wśród 5 metod CAM refundowanych z powszechnego ubezpieczenia (art. 118a Konstytucji; lista BAG: medycyna antroposoficzna, farmakoterapia TCM, akupunktura, klasyczna homeopatia, fitoterapia). **Niemcy** — kontrakty selektywne kas chorych GKV (dane refundacyjne wymagają weryfikacji w subzapytaniu v20C-DE). **Holandia** — refundacja w niektórych ubezpieczeniach.

Status w PL

NIE wymieniona w Stanowisku NRL Nr 2/21/VIII (Test Koniunkcji POZYTYWNY); poza systemem refundacji NFZ; preparaty Iscador/Helixor dostępne tylko przez import lub kliniki integracyjne.

Potencjalny status w UD207

WYSOKIE RYZYKO. Lekarz podający jemiolo pacjentowi onkologicznemu w PL — ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna” mimo refundacji w CH/DE. Paradoks UE: ten sam preparat jest standardem w CH od 2017 r., w PL może skutkować sankcją 1 mln zł.

Wnioski

Klasyczny dowód asymetrii regulacyjnej w UE. Para 2 z Części III v1.0 ilustruje paradoks vs olaratumab.

Karta 27 — Ayurweda w opiece onkologicznej

Atrybut

Treść

Definicja

Tradycyjny indyjski system medyczny rozwijany od ponad 3000 lat. Łączy ziołolecznictwo, dietę, panchakarma (terapia oczyszczająca), jogę i medytację. W opiece onkologicznej stosowana w opiece

Status w wytycznych

wspierającej i medycynie integracyjnej.

WHO TM Strategy 2025–2034 — wsparcie integracji ayurwedy. Brak rekomendacji ESMO/NCCN/ASCO.

Najsilniejsze RCT/dowody

Ograniczone RCT; przewaga obserwacji klinicznych. Ashwagandha (*Withania somnifera*) — RCT w zmęczeniu po chemioterapii.

OCEBM

3–4

GRADE

Low

Refundacja zagraniczna

Indie — ayurweda w pełni zintegrowana w systemie ochrony zdrowia (Ministry of AYUSH). USA — programy ayurwedy w **Maharishi University** i **Cleveland Clinic Center for Integrative Medicine**.

Status w PL

Brak regulacji; ayurweda jako działalność prywatna/wellness.

Potencjalny status w UD207

WYSOKIE RYZYKO. Terapeuta ayurwedy bez tytułu medycznego oferujący wsparcie pacjentom onkologicznym — silne ryzyko sankcji UD207.

Wnioski

System medyczny z 3000-letnią tradycją uznany przez WHO; w PL pełne ryzyko UD207.

Karta 28 — Homeopatia w opiece onkologicznej

Atrybut

Treść

Definicja

System medyczny wymyślony przez Samuela Hahnemanna w XIX w., oparty na zasadzie *similia similibus curentur* i potencjalizacji rozcieńczeń. Najbardziej kontrowersyjny system w obszarze CAM — dowody EBM bardzo ograniczone.

Status w wytycznych

Brak rekomendacji ESMO/NCCN/ASCO. **NHMRC Australia 2015** — przegląd negatywny: brak dowodów skuteczności w jakimkolwiek wskazaniu. **EASAC 2017** (European Academies' Science Advisory Council) — krytyczne stanowisko. **Niemcy** — usunięcie homeopatii z koszyka świadczeń publicznych planowane 2024–2025.

Najsilniejsze RCT/dowody

Cochrane systematic reviews — brak

OCEBM

GRADE

Refundacja zagraniczna

istotnego efektu klinicznego ponad placebo. Wyjątek: niektóre badania w opiece paliatywnej i w QoL — niejednoznaczne.

4–5

Very low

Szwajcaria — od 2017 r. wśród 5 metod CAM refundowanych z powszechnego ubezpieczenia (art. 118a Konstytucji; status uzyskany w **referendum z 2009 r.**, 67% poparcie). **Francja** — refundacja stopniowo wycofywana 2019–2021.

Niemcy — wycofanie z koszyka publicznego planowane 2024–2025. **Indie** — homeopatia zintegrowana w systemie (Ministry of AYUSH).

Status w PL

Homeopatia praktykowana przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami; preparaty homeopatyczne zarejestrowane w URPL (zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE art. 14 i 16).

Potencjalny status w UD207

EKSTREMALNIE WYSOKIE RYZYKO.

Homeopatia ma najsłabsze dowody EBM z 25 metod Części II. Mimo to: (a) preparaty zarejestrowane w URPL; (b) refundowana w Szwajcarii po referendum. Paradoks: status legalny PL → ryzyko sankcji UD207 mimo legalnej rejestracji.

Wnioski

Najsłabsze dowody EBM; mimo to status regulacyjny PL/UE skomplikowany. Casus Europejskiej różnorodności podejść do homeopatii.

IId. Biologically-Based / Diet (Karty 29–33)

Karta 29 — Dieta i żywienie w opiece onkologicznej

Atrybut

Treść

Definicja

Specjalistyczne doradztwo żywieniowe dla pacjentów onkologicznych: dieta przeciwzapalna, dieta śródziemnomorska, dieta roślinna (plant-based), modyfikacje przy malnutrition, sarkopenii, cachexii.

Status w wytycznych

ESPEN Guidelines on Nutrition in Cancer

Najsilniejsze RCT/dowody

Patients 2021. ASCO Survivorship Guidelines. WCRF/AICR Cancer Prevention Recommendations 2018 — dieta wpływa na ryzyko nowotworów i przeżycie. **WHO/IARC Monographs.**

WHEL Study (Pierce J.P. et al.) — dieta bogata w warzywa i owoce w raku piersi *JAMA* PMID 17635889. WINS Study (Chlebowski R.T. et al.) — dieta niskotłuszczowa w raku piersi *J Natl Cancer Inst* PMID 17151326. Metaanalizy: dieta śródziemnomorska i przeżycie.

OCEBM

1–2

GRADE

Moderate–High dla prewencji wtórnej

Refundacja zagraniczna

Dietetyk jako zawód medyczny w większości państw UE i USA. W PL od 2025 r. dietetyk jako zawód medyczny (ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych).

Status w PL

Dietetyk jako zawód medyczny od 2025 r.; specjalizacja w dietetyce onkologicznej.

Potencjalny status w UD207

NISKIE RYZYKO dla dietetyki konwencjonalnej. **WYSOKIE RYZYKO** dla diet “alternatywnych” (dieta ketogeniczna w GBM, post terapeutyczny, dieta surowa, dieta Gerson) — zob. karta 30.

Wnioski

Dietetyka mainstream — niskie ryzyko UD207. “Diety alternatywne” promowane jako leczenie onkologiczne — wysokie ryzyko.

Karta 30 — Post terapeutyczny i dieta naśladowująca post (Fasting-Mimicking Diet)

Atrybut

Treść

Definicja

Krótkoterminowy post (24–72 h) wokół podania chemioterapii lub dieta naśladowująca post (FMD — Fasting-Mimicking Diet, ProLon, opracowana przez Valter Longo, USC) — okresowa redukcja kalorii i białka symulująca efekt postu. W onkologii badana jako modyfikator odpowiedzi na chemioterapię i radioterapię.

Status w wytycznych

Brak rekomendacji ESMO/NCCN jako

Najsilniejsze RCT/dowody	standardowe leczenie. NCI — wymienia jako kierunek badań. de Groot S. et al. (DIRECT trial) — RCT FMD przed/podczas chemioterapii w raku piersi, n=131, <i>Nat Commun</i> PMID 32576828 — modulacja toksyczności i odpowiedzi. Mayo Clinic, Memorial Sloan Kettering — trwające badania kliniczne.
OCEBM	2–3 (RCT fazy II)
GRADE	Low–Moderate (obejujący kierunek, wymaga walidacji fazy III)
Refundacja zagraniczna	Brak refundacji; FMD ProLon dostępna komercyjnie.
Status w PL	Brak regulacji; praktykowana w klinikach integracyjnych.
Potencjalny status w UD207	WYSOKIE RYZYKO. Promocja postu jako “leczenia raka” — bardzo wysokie ryzyko sankcji. Post jako wsparcie chemioterapii (z monitorowaniem) — w polu szarym.
Wnioski	Aktywny kierunek badań z istotnymi RCT fazy II. Polski system nie ma jasnych granic dla tego rodzaju interwencji.

Karta 31 — Kanabinoidy medyczne w opiece onkologicznej

Atrybut	Treść
Definicja	Medyczne stosowanie produktów konopnych zawierających THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol) lub ich syntetycznych pochodnych (dronabinol, nabilon). W onkologii stosowane w bólu nowotworowym, mdłościach pochemioterapeutycznych, jadłowstręcie.
Status w wytycznych	NCCN Adult Cancer Pain Guidelines — kannabinoidy jako część zintegrowanej opieki przeciwbólowej. ASCO Guidelines for the Use of Antiemetics 2020 — dronabinol i nabilon w opornym CINV. FDA — dronabinol (Marinol®) zarejestrowany od 1985 r. dla CINV i AIDS-related anorexia.
Najsilniejsze RCT/dowody	Metaanalizy w bólu nowotworowym — istotna redukcja bólu opornego na opioidy.

OCEBM

GRADE

Refundacja zagraniczna

Status w PL

Potencjalny status w UD207

Wnioski

Metaanaliza w CINV opornym — istotny efekt.

1–2

Moderate

USA (~38 stanów) — medical cannabis legalny w onkologii. **Niemcy** — refundacja przez kasy chorych od 2017 r. **Holandia, Czechy, Włochy** — refundacja medical cannabis.

Marihuana medyczna zarejestrowana od **2017 r.** (ustawa z 7.07.2017); susz konopny w aptekach na receptę. **Refundowana** w wybranych wskazaniach (m.in. stwardnienie rozsiane). W onkologii — dostępna na receptę, refundacja ograniczona.

NISKIE RYZYKO — kannabinoidy zarejestrowane w PL od 2017 r. ALE: stosowanie “samodzielnych” preparatów CBD z niewiadomego źródła i bez recepty — w polu szarym.

Klasyczna kategoria medycyny komplementarnej, która przeszła do mainstream PL od 2017 r. Argument: paradoks — kannabinoidy są wyłączone z dyskusji “pseudomedycyny” mimo wcześniejszej kontrowersji.

Karta 32 — Gut microbiome i probiotyki w opiece onkologicznej

Atrybut

Treść

Definicja

Modulacja mikrobioty jelitowej (probiotyki, prebiotyki, postbiotyki, dieta wysokobłonnikowa, fecal microbiota transplantation — FMT) w onkologii. **Przełomowa dziedzina 2024–2026:** wpływ mikrobioty na odpowiedź na immunoterapię (immune checkpoint inhibitors, ICI).

Status w wytycznych

Brak formalnych rekomendacji ESMO/NCCN. **Aktywne pole badań** — publikacje w *Science*, *Nature*, *Cell* (2022–2026).

Najsilniejsze RCT/dowody

Gopalakrishnan V. et al. — wpływ

OCEBM**GRADE****Refundacja zagraniczna****Status w PL****Potencjalny status w UD207****Wnioski**

mikrobioty na odpowiedź na anti-PD-1 w czerniaku *Science* PMID 29097493. Davar D. et al. — RCT fecal microbiota transplantation modulujący odpowiedź na anti-PD-1 *Science* PMID 33542131. Routy B. et al. — *Science* PMID 29097494.

2–3 (RCT i prospektywne kohorty)

Moderate (obietujące, wymaga walidacji w większych badaniach)

USA — programy FMT w czołowych ośrodkach (MD Anderson Microbiome Research Center). Probiotyki — bez statusu leczenia onkologicznego.

Probiotyki jako suplementy diety; FMT w wybranych ośrodkach w PL w *C. difficile* infection.

NISKIE RYZYKO dla badań klinicznych z FMT. **WYSOKIE RYZYKO** dla promowania probiotyków jako “leczenia raka”.

Najbardziej przełomowa dziedzina współczesnej onkologii integracyjnej — wpływa na efektywność immunoterapii. Polska regulacja nie nadąża za stanem nauki.

*Karta 33 — Soja i izoflawonoidy w opiece onkologicznej***Atrybut****Treść****Definicja**

Konsumpcja soi i preparatów zawierających izoflawonoidy (genisteina, daidzeina) w profilaktyce nowotworów hormonozależnych (rak piersi, prostata) i w opiece wspierającej (vasomotor symptoms u kobiet po raku piersi).

Status w wytycznych

ACS Guidelines for Cancer Survivors — soja dietetyczna nie jest przeciwwskazana u survivors raka piersi. **NCCN Survivorship Guidelines** — dieta z umiarkowaną konsumpcją soi bezpieczna. **AICR** (American Institute for Cancer Research) — soja dietetyczna może być korzystna w prewencji.

Najsilniejsze RCT/dowody

Shu X.O. et al. — Shanghai Breast Cancer Survival Study, kohorta n=5042 — istotne

	związane z konsumpcją soi przedłużenie OS w raku piersi <i>JAMA</i> PMID 19996398. Metaanaliza: Nechuta S.J. et al. <i>Am J Clin Nutr</i> PMID 22648714.
OCEBM	1–2
GRADE	Moderate (dla diety; low dla preparatów wysokoskoncentrowanych)
Refundacja zagraniczna	Soja jako dieta — bez statusu leczenia. Preparaty izoflawonoidów — suplementy.
Status w PL	Suplementy izoflawonoidów dostępne OTC.
Potencjalny status w UD207	NISKIE RYZYKO dla soi dietetycznej. WYSOKIE RYZYKO dla promowania izoflawonoidów jako “leczenia” raka piersi/prostaty.
Wnioski	Dieta z umiarkowaną konsumpcją soi rekomendowana; preparaty wysokoskoncentrowane — niepotwierdzone.

Ile. Energy / Other Therapies (Karty 34–38)

Karta 34 — *Healing Touch, Therapeutic Touch, Reiki*

Atrybut	Treść
Definicja	Terapie energetyczne polegające na “transferze energii” przez ręce terapeuty (z kontaktem fizycznym lub bez). Reiki — system z Japonii. Healing Touch — system amerykański (American Holistic Nurses Association).
Status w wytycznych	Brak silnych rekomendacji ASCO/SIO/NCCN. Niektóre programy w opiece paliatywnej.
Najsilniejsze RCT/dowody	Małe RCT w lęku i bólu — efekty często nieistotne statystycznie ponad efekt placebo lub kontakt terapeutyczny.
OCEBM	3–4
GRADE	Low
Refundacja zagraniczna	USA — Reiki w programach Memorial Sloan Kettering Integrative Medicine i Dana-Farber Zakim Center (bez refundacji jako “leczenie”, ale jako element komfortu

Status w PL

pacjenta).

Brak regulacji; Reiki jako zawód nieregulowany.

Potencjalny status w UD207

EKSTREMALNIE WYSOKIE RYZYKO.

Reiki/Healing Touch jako “leczenie energetyczne” — najwyższe ryzyko interpretacji jako “praktyka pseudomedyczna” w PL.

Wnioski

Najsłabsze dowody z terapii Części II; jednocześnie używane w czołowych amerykańskich ośrodkach jako element komfortu, nie leczenia.

Karta 35 — Aromaterapia w opiece onkologicznej

Atrybut

Treść

Definicja

Stosowanie olejków eterycznych (lawenda, mięta, imbir, cytryna) inhalacyjnie lub przez masaż w opiece pacjenta onkologicznego — głównie w mdłościach, lęku, zaburzeniach snu.

Status w wytycznych

Brak silnych rekomendacji ESMO/NCCN. **NHS UK** — aromaterapia w hospicjach onkologicznych.

Najsilniejsze RCT/dowody

Małe RCT w mdłościach pooperacyjnych (lawenda, mięta) — niejednoznaczne. Cochrane — ograniczone dowody.

OCEBM

3–4

GRADE

Low

Refundacja zagraniczna

UK — aromaterapia w hospicjach onkologicznych (Macmillan).

Status w PL

Brak regulacji; aromaterapia jako działalność wellness.

Potencjalny status w UD207

WYSOKIE RYZYKO. Aromaterapeuta oferujący “wsparcie onkologiczne” — wysokie ryzyko sankcji.

Wnioski

Słabe dowody; w UK refundowana w hospicjach jako element komfortu.

Karta 36 — Muzykoterapia w opiece onkologicznej

Atrybut

Treść

Definicja

Profesjonalna interwencja kliniczna z wykorzystaniem muzyki w opiece

	onkologicznej — dla redukcji lęku, bólu, mdłości, w opiece paliatywnej. Prowadzona przez certyfikowanego muzykoterapeutę (Music Therapist, MT-BC w USA).
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 — muzykoterapia rekomendowana w lęku okołoperacyjnym i opiece paliatywnej (moderate strength).
Najsilniejsze RCT/dowody	Bradt J. et al. — Cochrane systematic review of music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients <i>Cochrane Database Syst Rev</i> PMID 27524661.
OCEBM	1–2
GRADE	Moderate
Refundacja zagraniczna	UK NHS — muzykoterapia w hospicjach i opiece paliatywnej. USA — programy w MSK, Dana-Farber, Mayo.
Status w PL	Muzykoterapeuta jako zawód nieregulowany; programy w niektórych szpitalach onkologicznych i hospicjach.
Potencjalny status w UD207	NIEPEWNE. Muzykoterapeuta w podmiocie leczniczym — niskie ryzyko. Muzykoterapeuta w gabinecie prywatnym z reklamą “leczenia onkologicznego” — wyższe ryzyko.
Wnioski	Silne dowody; rekomendacja ASCO/SIO 2022. W PL granica regulacyjna nieostra.

Karta 37 — Terapie ekspresyjne (pisanie, taniec/ruch, journaling)

Atrybut	Treść
Definicja	Terapie ekspresyjne wykorzystujące pisanie (expressive writing, journaling, Pennebaker paradigm) lub taniec/ruch (medical dance/movement therapy) w przetwarzaniu doświadczenia choroby onkologicznej.
Status w wytycznych	Brak formalnych rekomendacji ASCO/SIO/NCCN.
Najsilniejsze RCT/dowody	Pennebaker J.W. — klasyczne badania expressive writing <i>Psychol Sci</i> PMID 11784031. RCT w opiece onkologicznej —

	ograniczone.
OCEBM	3
GRADE	Low–Moderate
Refundacja zagraniczna	Programy w czołowych ośrodkach US (MSK, MD Anderson Integrative Medicine).
Status w PL	Brak regulacji; choreoterapia / arteterapia jako specjalizacje psychologiczne i pedagogiczne.
Potencjalny status w UD207	NIEPEWNE. Terapeuta ekspresyjny w podmiocie leczniczym jako element opieki psychologicznej — niskie ryzyko.
Wnioski	Słabsze dowody; w czołowych ośrodkach US jako element komfortu pacjenta.

Karta 38 — Guided Imagery i Progressive Muscle Relaxation

Atrybut	Treść
Definicja	Techniki relaksacyjne: guided imagery — kierowane wyobrażenia z udziałem przewodnika; progressive muscle relaxation (PMR) Jacobson — sukcesywne napinanie i rozluźnianie grup mięśni. Stosowane w lęku, bólu, mdłościach, opiece okołoonkologicznej.
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 — relaksacja (w tym PMR) w lęku (moderate strength). NCCN Distress Management Guidelines — guided imagery i PMR jako interwencje nefarmakologiczne.
Najsilniejsze RCT/dowody	Metaanalizy w lęku i bólu okołoperacyjnym — istotne efekty.
OCEBM	1–2
GRADE	Moderate
Refundacja zagraniczna	USA — programy w MSK, Dana-Farber. UK — w hospicjach.
Status w PL	Stosowane przez psychologów i terapeutów; brak formalnej rejestracji jako odrębne metody.
Potencjalny status w UD207	NISKIE RYZYKO w gabinecie psychologa/psychoterapeuty.
Wnioski	Silne dowody, rekomendacja ASCO/SIO; w PL część praktyki psychologicznej.

II. Special Populations (Karty 39–40)

Karta 39 — *Pediatryczna onkologia integracyjna*

Atrybut	Treść
Definicja	Onkologia integracyjna specyficznie dla dzieci i młodzieży chorych na nowotwory — adaptowane metody opieki wspierającej (akupunktura, masaż, joga, muzykoterapia, mindfulness, arteterapia).
Status w wytycznych	COG (Children’s Oncology Group) — programy integrative w supportive care. St. Jude Children’s Research Hospital — Integrative Medicine Program.
Najsilniejsze RCT/dowody	Akupunktura w CINV pediatrycznym — Cochrane reviews. Hipnoza w bólu proceduralnym dziecięcym — silne dowody.
OCEBM	2
GRADE	Moderate
Refundacja zagraniczna	USA — Integrative Medicine programs w St. Jude, Boston Children’s, CHOP, MSK Kids.
Status w PL	Onkologia dziecięca w PL nie ma formalnych programów integrative; dzieci leczone w jednostkach pediatrycznych według standardowych protokołów.
Potencjalny status w UD207	WYSOKIE RYZYKO przy szerokiej interpretacji. Akupunktura/hipnoza/joga u dziecka z nowotworem w prywatnym ośrodku integracyjnym — silne ryzyko sankcji.
Wnioski	Standardem opieki w czołowych pediatrycznych ośrodkach onkologicznych USA; w PL brak takich programów.

Karta 40 — *Integrative end-of-life care*

Atrybut	Treść
Definicja	Onkologia integracyjna w opiece u kresu życia — masaż, akupunktura, aromaterapia, muzykoterapia, mindfulness w hospicjach onkologicznych.

Status w wytycznych	NHPCO (National Hospice and Palliative Care Organization USA) — integrative therapies w opiece paliatywnej. EAPC (European Association for Palliative Care) — wytyczne integrative w opiece u kresu życia.
Najsilniejsze RCT/dowody	Liczne kohorty i RCT w hospicjach — masaż w bólu opornym, muzykoterapia w lęku, aromaterapia w dyskomfortcie.
OCEBM	2–3
GRADE	Moderate
Refundacja zagraniczna	UK NHS — therapies refundowane w hospicjach (Macmillan, Marie Curie). USA — Medicare Hospice Benefit pokrywa integrative therapies.
Status w PL	Hospicja onkologiczne — masaż, aromaterapia, muzykoterapia stosowane jako element komfortu pacjenta; finansowanie z NFZ + środki własne organizacji pozarządowych.
Potencjalny status w UD207	NISKIE RYZYKO w hospicjach refundowanych; NIEPEWNE w prywatnej opiece paliatywnej.
Wnioski	Standard opieki paliatywnej w UE i USA; w PL część praktyki hospicyjnej.

CZĘŚĆ III — Paradoks refundacyjny: trzy reprezentatywne pary

(Zachowane bez zmian z v1.0)

Para 1 — Witamina C dożylna (Bodeker PACMAN 2.1) vs Bewacizumab (Avastin) w GBM

Para 2 — Iscador/jemiola (refundacja w CH/DE) vs Olaratumab (Lartruvo) — wycofany

Para 3 — FDA Project Confirm: 30+ wycofanych accelerated approvals

[Pełna treść Części III — zob. Załącznik 3 v1.0]

CZĘŚĆ IV — Wnioski

1. Asymetria standardu dowodowego

2. Brak gradacji dowodów w kryterium UD207

3. Gradacja dowodowa A-E

W v2.1 wprowadzamy **pięcio-poziomową gradację dowodową** zamiast wcześniejszej (subiektywnej) gradacji „ryzyka UD207”. Argument konstytucyjny w nowym ujęciu: **UD207 nie rozróżnia tych 5 poziomów dowodowych — traktuje wszystkie metody w sposób jednakowy, co stanowi naruszenie standardu *lex certa* i testu proporcjonalności.**

Poziom A — REKOMENDOWANE PRZEZ WYTYCZNE w konkretnych wskazaniach onkologicznych: - Akupunktura klasyczna w bólu związanym z inhibitorami aromatazy — **ASCO/SIO 2022 Pain Guideline** (DOI 10.1200/JCO.22.01357, PMID 36122322) - Joga w cancer-related fatigue — **NCCN kategoria 1**, NCI PDQ Fatigue (cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/fatigue/fatigue-hp-pdq) - Mindfulness / MBSR / MBSR w lęku i depresji — **ASCO/SIO 2023 Anxiety/Depression Guideline** (DOI 10.1200/JCO.23.00857) - Tai Chi / Qigong w zmęczeniu — **ASCO/SIO 2024 Fatigue Guideline** (PMID 38754041) - Aktywność fizyczna w opiece onkologicznej — **ACSM Roundtable 2019** (PMID 31626055) - Muzykoterapia w lęku okołoperacyjnym — **ASCO/SIO 2023 + Cochrane 2021** (PMID 34637527) - Cannabis/kannabinoidy w opornym bólu nowotworowym i CINV — **ASCO/SIO 2024 Cannabis Guideline** (PMID 38478773), FDA dronabinol od 1985

Poziom B — DOPUSZCZALNE jako supportive care z umiarkowaną bazą: - Hipnoza kliniczna w lęku okołoperacyjnym — RCT i przeglądy systematyczne (PMID 25233905 Cramer systematic review) - Masaż onkologiczny w bólu i lęku — Cochrane 2016 (PMID 27258432), kohorta MSK (PMID 15336336) - Guided imagery / Progressive Muscle Relaxation w lęku — NCCN Distress Management - Soja dietetyczna w opiece survivor raka piersi — Shu BCSS PMID 19996398, metaanaliza PMID 23725149 - Dieta śródziemnomorska / przeciwzapalna — WHEL PMID 17635889, ESPEN Guidelines 2021

Poziom C — EKSPERYMENTALNE / TRANSLACYJNE (obietujące, ale wymagają walidacji): - Mikrobiota jelitowa i FMT w odpowiedzi na immunoterapię — Science 2018 (PMID 29097493 Gopalakrishnan, 29097494 Routy), Davar 2021 PMID 33542131. **NIE klasyczna CAM** — to obszar translacyjnej immuno-onkologii. - Post terapeutyczny / fasting-mimicking diet w chemioterapii — DIRECT trial PMID 32576828 (de Groot 2020). Faza II — wymaga walidacji. - Witamina C dożylna w raku trzustki — PACMAN 2.1 PMID 39369582 (Bodeker 2024). Faza II — wymaga walidacji w fazie III.

Poziom D — SŁABE lub NEGATYWNE dowody (mimo refundacji w niektórych krajach): - Homeopatia — NHMRC Australia 2015 (przegląd negatywny), EASAC 2017 (krytyczne stanowisko). Refundacja CH od 2017 — decyzja regulacyjna oparta na referendum 2009, nie na dowodach EBM. - Refleksologia — przeglądy systematyczne

wskazują brak przekonującej skuteczności (PMID 21106613, 31783340). - Naświetlanie laserowe krwi (ILIB), galwanoterapia — brak RCT w onkologii.

Poziom E — BRAK WYSTARCZAJĄCYCH DANYCH / wymaga dalszej kwerendy: - Aromaterapia w opiece onkologicznej (poza hospicjami UK) - Healing touch / Reiki / Therapeutic touch - Ayurweda (ograniczone RCT) - Tradycyjne ziołolecznictwo chińskie (Compound Kushen, Astragalus) — dominacja chińskich RCT o niejednorodnej jakości metodologicznej - Manipulacja kręgosłupa w opiece onkologicznej

Konkluzja: standard regulacyjny UD207 powinien rozróżniać poziom A (już rekomendowany przez wytyczne międzynarodowe — wykluczyć z zakresu sankcji), poziom B (dopuszczalny pod warunkami świadomej zgody), poziom C (badania kliniczne na specjalnych ścieżkach), poziom D (klauzula informacyjna o jakości dowodów), poziom E (zakaz reklamy jako “leczenia”). **Obecna definicja art. 67zj nie wprowadza żadnego z tych rozróżnień.**

4. Argument *lex certa* (art. 2 i 42 ust. 1 Konstytucji RP)

Definicja “praktyki pseudomedycznej” w art. 67zj UD207 jest **strukturalnie nieokreślona** — adresat normy nie jest w stanie *ex ante* przewidzieć, czy stosowanie metody: - rekomendowanej w wytycznych ASCO/SIO 2022 (akupunktura, joga, mindfulness, muzykoterapia) - refundowanej w państwach UE (homeopatia w CH, jemioła w CH/DE, akupunktura w UK NHS, TCM w CH) - standardowo prowadzonej w czołowych ośrodkach onkologicznych USA (MSK, Dana-Farber, MD Anderson, Mayo Clinic) - opisanej w aktualnych akademickich kompendiach onkologii integracyjnej

zostanie zakwalifikowane jako “praktyka pseudomedyczna” przez Rzecznika Praw Pacjenta, wspieranego opiniami 34-osobowej Rady Ekspertów. Standard *lex certa* (wyrok TK z 5.07.2011 r. P 14/10 i in.) wymaga, by norma karząca była **przewidywalna** dla adresata przed wszczęciem postępowania.

5. Postulat — klauzula świadomej zgody jako proporcjonalne narzędzie

CZĘŚĆ V — Komparatystyka 7 krajów UE/UK

Streszczenie wykonawcze Części V

Niniejsza część prezentuje **modele regulacyjne CAM w 7 państwach UE/EFTA/UK:** Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Włochy, Austria, Polska. Pokazuje, że
**żadne z tych państw nie